

# Adaptacje *CBT* do psychozy

Standardowe CBT nie działa w psychozie — opór, dropout. CBTP różni się tempem, językiem, normalizacją i celem (dystres, nie eliminacja objawów).

**CZAS:** 15 min · psychoedukacja Po pierwszej psychoedukacji ogólnej

**ŹRÓDŁO:** Fowler/Garety/Kuipers (1995); Morrison (2017); NICE CG178; van der Gaag (2014)

## JAK UŻYWAĆ

Poznaj **siedem adaptacji**, które odróżniają CBTP od standardowego CBT (sekcja 1), zrozum *dlaczego cel CBTP jest inny* niż eliminacja objawów (sekcja 2) i wybierz **dwa obszary** do omówienia z terapeutą na najbliższej sesji (sekcja 3).

## DLACZEGO TO DZIAŁA

CBTP (Fowler/Garety/Kuipers 1995; Morrison 2017) jest **rekomendowane przez NICE CG178** jako leczenie *obok* farmakoterapii dla każdej osoby z psychozą. Meta-analiza Wykes i in. (2008, 34 RCT): wielkość efektu  $d = 0,37$  dla objawów pozytywnych,  $d = 0,44$  dla nastroju,  $d = 0,38$  dla funkcjonowania społecznego. Kluczowa różnica: **cel nie jest eliminacja objawów**, lecz zmiana relacji z nimi i redukcja dystresu. Standardowe CBT bez adaptacji często prowadzi do oporu — pacjent czuje, że klinicysta „chce go przekonać, że nie ma racji”.

## 01 Siedem adaptacji odróżniających CBTP

### 1 · DŁUGI ENGAGEMENT

3–5 sesji przeznaczonych *tylko* na budowę relacji. Brak agendy „terapeutycznej” — rozmowa o tym, co ważne dla pacjenta.

### 2 · WSPÓLNA FORMULACJA

Model podatność–stres budowany *razem* z pacjentem. Nie wykład — wspólne odkrycie, skąd wzięły się objawy.

### 3 · NORMALIZACJA

5–15% populacji ogólnej słyszy głosy. Niezwykle przekonania są na *kontinuum*. Redukcja wstydu otwiera rozmowę.

### 4 · ŁAGODNE EKSPERYMENTY

„Sprawdźmy razem” zamiast „to nieprawda”. Empiryzm współpracujący (ang. *collaborative empiricism*) — pacjent sam dochodzi do wniosków.

### 5 · CEL: DYSTRES, NIE PRZEKONANIE

CBTP nie próbuje *obniżyć conviction do zera*. Cel: *distress = 3 zamiast 9* przy tym samym *conviction*.

### 6 · REDUKCJA ZACHOWAŃ BEZPIECZEŃSTWA

Stopniowe zmniejszanie unikania, sprawdzania, rytuałów ochronnych — utrzymują lęk i przekonania.

### 7 · PROFILAKTYKA NAWROTÓW

Identyfikacja *wczesnych sygnałów* nawrotu (sen, niepokój, izolacja) + plan działania na 3 poziomach. Birchwood (1989): wczesne wykrycie redukuje hospitalizację o 50%.

## 02 Inny cel — inna terapia

### STANDARDOWE CBT

Cel: zmiana *treści* myśli. Konfrontacja zniekształceń poznawczych. Tempo szybkie, sesje 60 min, agenda strukturyzowana. Dla depresji, lęku, OCD — działa.

### CBTP

Cel: zmiana *relacji* z objawami. Eksploracja zamiast konfrontacji. Tempo wolne, sesje 30–45 min, elastyczna agenda. Dostosowane do specyfiki psychozy.

Morrison (2017): „*nie zwalczamy urojenia — pomagamy mózgowi zebrać nowe dane*”. Praca z urojeniami i głosami przebiega **czterema fazami**: sojusz (sesje 1–4) → konceptualizacja problemu (5–10) → praca z konkretnymi objawami (11–22) → profilaktyka nawrotów (23–26). Tempo dopasowane indywidualnie.

## 03 Moje dwa obszary do omówienia

Wybierz **dwie** z siedmiu adaptacji (sekcja 1), które chcesz omówić z terapeutą — albo to, czego brakuje, albo to, co działa najlepiej. Zabierz tę kartę na sesję.

### OBSZAR 1

— co chcę omówić

---

---

---

### OBSZAR 2

— co chcę omówić

---

---

---

**Klucz:** CBTP *nie* jest „przekonywaniem, że nie masz psychozy” — to **pomaganie w życiu z doświadczeniami, które masz, w sposób który mniej boli**. Van der Gaag i in. (2014, metaanaliza 8 RCT): CBTP redukuje dystres i wpływ objawów na funkcjonowanie, nawet gdy *częstotliwość* objawów się nie zmienia. To znaczy: można żyć dobrze z głosami i dziwnymi przekonaniami, jeśli nie sterują życiem. NICE CG178: CBTP **od pierwszego epizodu**, równolegle z farmakoterapią, minimum 16 sesji.